

# RELATÓRIO DE AULA - MEDCEL

## 1. RESUMO EXECUTIVO (IA)

**\*\*Resumo Executivo Médico\*\***

**\*\*Principais Diagnósticos:\*\***

- Hidropsia fetal não imune
- Anemia grave
- Edema (hidropsia fetal)
- Possível pré-eclâmpsia
- Anemia falciforme ou traço falcêmico
- Malária (em regiões endêmicas)
- Diabetes gestacional (se a glicemia for abaixo de 92 mg/dL)
- Infecções sexualmente transmissíveis (IST) (clamídia, gonococo)
- Infecções parasitárias (toxoplasmose)
- Infecções virais (HIV, hepatite B)
- Infecções bacterianas (estreptococcus do grupo B)

**\*\*Condutas Sugeridas:\*\***

- Realizar ultrassonografia para avaliar a gestação, localizar o número de sacos gestacionais, avaliar a vitalidade embrionária e detectar sinais de mal prognóstico
- Realizar exame de secreção vaginal para detectar infecções
- Realizar eletroforese de hemoglobina para detectar anemia falciforme ou traço falcêmico
- Realizar testes rápidos para detectar IST (clamídia, gonococo), HIV, hepatite B e estreptococcus do grupo B
- Realizar ultrassonografia morfológica no primeiro trimestre (6-9 semanas), segundo trimestre (18-24 semanas) e terceiro trimestre (34-36 semanas)
- Realizar exame de sangue para detectar anemia grave e diabetes gestacional
- Realizar exame de urina para detectar infecções bacterianas
- Realizar exame de fezes para detectar infecções parasitárias (toxoplasmose)
- Realizar exame de sangue para detectar infecções virais (HIV, hepatite B)

**\*\*Pontos de Atenção para Provas:\*\***

- Realizar ultrassonografia para avaliar a gestação e detectar sinais de mal prognóstico
- Realizar exame de secreção vaginal para detectar infecções
- Realizar eletroforese de hemoglobina para detectar anemia falciforme ou traço falcêmico
- Realizar testes rápidos para detectar IST (clamídia, gonococo), HIV, hepatite B e estreptococcus do grupo B

- Realizar ultrassonografia morfológica no primeiro trimestre (6-9 semanas), segundo trimestre (18-24 semanas) e terceiro trimestre (34-36 semanas)
- Realizar exame de sangue para detectar anemia grave e diabetes gestacional
- Realizar exame de urina para detectar infecções bacterianas
- Realizar exame de fezes para detectar infecções parasitárias (toxoplasmose)
- Realizar exame de sangue para detectar infecções virais (HIV, hepatite B)

**\*\*Observações:\*\***

- É importante realizar uma avaliação cuidadosa da gestação e detectar sinais de mal prognóstico
- É importante realizar exames de secreção vaginal, eletroforese de hemoglobina, testes rápidos e ultrassonografia morfológica para detectar infecções e anormalidades
- É importante realizar exames de sangue e urina para detectar anemia grave, diabetes gestacional e infecções bacterianas
- É importante realizar exames de fezes para detectar infecções parasitárias (toxoplasmose)
- É importante realizar exames de sangue para detectar infecções virais (HIV, hepatite B)

## 2. TRANSCRIÇÃO ESTRUTURADA (IA)

Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula desse nosso curso mega importante para você garantir a sua prova aí, para ser aprovado, é tudo que a gente espera e é o que a gente quer.

Quais são os principais pontos a serem abordados durante uma gestação de baixo risco? Será que você sabe me dizer? Nós vamos abordar isso hoje na assistência pré-natal. Então essa é uma aula super importante, é tema de prova frequente e vocês têm que saber.

Qual que é o objetivo da assistência pré-natal, então? A gente tem alguns objetivos. O primeiro deles é diagnosticar e confirmar a gravidez, que a gente pode fazer pelo teste rápido, um teste de urina. A gente diagnostica doenças pré-existentes. Aqui, idealmente, é que ela tivesse feito algo pré-concepcional, antes mesmo de iniciar o pré-natal.

Proporciona a rigidez ao organismo materno e fetal, ou pelo menos tenta, porque na verdade nem sempre a gente vai conseguir. E ampara socialmente e psicologicamente essa paciente. Prepara para o parto e para a maternidade. E cuida da parceria. A parceria é o parceiro mesmo, o marido ou a esposa, né? Enfim, a gente precisa também ter esse cuidado e fazer o pré-natal da parceria também, porque isso também vai contribuir ali, tanto para a assistência pré-natal, quanto para o momento pós-parto.

E para finalizar os objetivos, a gente orienta os direitos previstos em lei. Então, quanto de licença maternidade, o que pode fazer, se pode afastar, se não pode, enfim, detalhes de direitos previstos e lei também acaba sendo um pouco de nossa responsabilidade.

E qual que é o ideal de consultas? Então, antes de mais nada, o ideal é que a gente faça uma consulta pré-concepcional. Então, essa mulher deveria passar em consulta médica conosco para a gente solicitar vários exames.

Quais são eles? Então sorologia, para avaliar as vacinas que ela pode tomar, porque existem vacinas que não podem ser feitas na gravidez, mas que valem a pena serem feitas antes de engravidar, para aquelas que não tem o cartão vacinal, por exemplo, atualizado. A gente avalia as doenças e além de avaliar as doenças, a gente ajusta as medicações, obviamente.

Avaliar os hábitos de alimentação, o ideal é que essa paciente faça exercício físico, que ela se alimente de forma adequada. A questão dos medicamentos que eu acabei dizendo nas comorbidades, então a gente ajusta. Será que ela toma algum medicamento que não pode ser tomado durante a gravidez? Nós vamos ajustar isso.

E a gente avalia as condições de trabalho. Será que ela tem alguma condição no trabalho que possa ser prejudicial para uma gestação? E aí a gente vai orientá-la em relação a isso. E avalia o parceiro. O parceiro também é muito importante no processo. O parceiro saudável também ajuda, contribui para uma gestação saudável.

E se a gente for pensar em primeira consulta, quando que deve ser a primeira consulta de uma paciente que descobriu a gravidez? No primeiro trimestre, o mais precocemente possível. E aí nesse momento também a gente determina aquelas que vão precisar de acompanhamento especializado. É uma gestação de alto risco que eu preciso encaminhá-la para algum serviço ou para um pré-natal de alto risco?

Então, nesse momento, é a hora da gente decidir se essa paciente procura, procura não, é encaminhada ou não a um serviço de maior complexidade. Números de consultas. Então, a gente tem duas formas de analisar. Pelo Ministério da Saúde, que é o principal, que cai na prova de vocês, é um mínimo de seis. Seria uma consulta no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre

e três no terceiro trimestre.

Mas vamos pensar num cenário ideal, qual seria o ideal para a gente ter de consulta pré-natal? Numa paciente de baixo risco. A gente conduzia essa paciente até a 28ª semana de forma mensal, da 28ª até a 36ª semana quinzenal e da 36ª até a 41ª de forma semanal. Lembrando que não existe alta do pré-natal. Então se voltar uma mulher para o posto de saúde, para a UBS, dizendo que não entrou em trabalho de parto, que não ganhou o bebê e quiser marcar uma consulta e ela está grávida, tem que marcar, porque ela não tem alta até o nascimento.

E o cuidado continua, inclusive após o nascimento. Nasceu, ela volta para o puerpério, para as primeiras consultas ali de puerpério. Lembrando que 90% das pacientes serão de baixo risco, se a gente for pensar em sistema único de saúde, o segmento vai ser na atenção básica. Somente 10% das pacientes vão ter alguma doença pré-existente para caracterizar alto risco. Ou que tem uma história reprodutiva com mal passado obstétrico, por exemplo, com perda fetal tardia, com algum cenário triste.

Uma história triste que faça com que a gente encaminhe para o alto risco. Alterações fetais e maternas na gestação atual. Então, imaginem vocês que ela faz, por exemplo, uma restrição de crescimento intrauterino. Vou encaminhá-la para o alto risco. Fez pré-eclâmpsea, vai para o alto risco. Então, essas pacientes precisam ser cuidadas num serviço especializado.

E aí, quando ela chega na primeira consulta, a gente precisa avaliar se ela tem algum risco, algum problema que possa afetar a gestação. E aí, a gente pode encaminhá-la para um serviço de maior complexidade, se necessário. E aí, é importante lembrar que a assistência pré-natal é fundamental para garantir uma gestação saudável e um parto seguro.

Aqui está o texto pontuado e organizado em parágrafos:

A anamnese é uma parte fundamental da consulta médica, especialmente em gestantes. Nela, identificamos a paciente, pedimos dados socioeconômicos, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos e analisamos a gestação atual. É anamnese básica, mas em gestantes, precisamos incluir ginecológicos, obstétricos e a gestação atual para avaliá-la adequadamente.

Em toda consulta, é importante utilizar o método mnemônico DOM, DOP, ADOP, DCC e DG. DOM significa Diagnóstico Obstétrico de Normalidade, ou seja, como está a gestação? É uma primigesta ou uma secundigesta? Qual é a idade gestacional dela? DOP significa Diagnóstico Obstétrico Patológico Atual, ou seja, tem algum problema de saúde nessa gestação? ADOP significa Diagnóstico Obstétrico Patológico Pgresso, ou seja, não teve algum problema de saúde nessa gestação, mas teve na gestação anterior. DCC significa Diagnóstico Clínico Cirúrgico, ou seja, tem alguma coisa, como hipertensão crônica de base. E DG significa Diagnóstico Ginecológico, ou seja, alguma alteração ginecológica.

O pré-natal é importante porque visa reduzir a mortalidade materna e melhorar o desfecho, tanto materno quanto fetal. Queremos recém-nascidos saudáveis e mulheres saudáveis. As principais causas de morte no Brasil são hipertensão, hemorragia e infecção. Precisamos prevenir essas causas e tratar as infecções de forma oportuna.

A prematuridade é um problema importante, pois é a principal causa de óbito neonatal não associada a malformações congênitas. Precisamos minimizar as possibilidades de prematuridade e ficar atento ao histórico de perdas gestacionais e prematuridade prévia. O principal fator de risco para ter um parto prematuro é ter tido um parto prematuro anterior.

A idade gestacional é importante calcular, pois é a data provável do parto. A data provável do parto não é a data que o neném vai nascer, mas sim quando a paciente completa 40 semanas de gravidez. A regra de Neigeli é uma forma de calcular a data provável do parto. Se a data da última menstruação foi em janeiro, fevereiro ou março, somamos sete dias da data do dia dessa última menstruação e somamos nove meses. Se a data da última menstruação foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, somamos 7 dias, diminuimos 3 meses e somamos 1 ano.

Ano. Vamos entender como é que fica isso? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Fica bem mais fácil de compreender quando a gente vê esses números.

Então vamos imaginar uma paciente que tem a data da última menstruação de 15 de dezembro de 2025. Como é que eu vou calcular DPP? Eu pego os 15, que é o dia, somo 7, vai dar 22. Como o mês foi dezembro, eu vou subtrair 3. 12 menos 3 igual a 9. O ano é de 2025. Vocês concordam que não vai nascer em 2025? Ela engravidou em dezembro de 2025. Não vai nascer em 2025. Então, tem que virar o ano para 2026. DPP 22 do 9 de 26. Agora, se a DUM foi 2 do 3 de 26. Vamos lá. Dia 2 mais 7, 9. O mês agora, como foi março, eu vou somar 9. Então 9 mais 3, 12. E o ano se mantém, porque ela engravidou em março e vai nascer a princípio no mesmo ano. 2, cadê? 9 de dezembro de 2026. Então ficou no mesmo ano. E é óbvio, né gente? Porque assim, 2 de março de 2026. Eu não posso virar o ano para 2027 e nascer 9 de dezembro de 2027. Não é gestação de elefante isso aqui. Então também tem que ter um pouquinho de lógica para compreender, sabe? Então é mais 7 e mais 9 se for até março e menos 3 se for de abril em diante. Mas aí tem esse cenário, né? E quando vira o mês? Então vamos pensar aqui, 25 do 4 de 25. Na hora que eu somo 7, virou 2. Mas vocês concordam que isso aqui virou o mês? Na hora que vira o mês, em vez de eu subtrair 3, eu vou subtrair 2. E aí o ano de 2025 mais 1 de 2026, 2 do 2 de 2026. E se a DUM for 25 do 1 de 26, por exemplo? 25 mais 7 é 1, porque aqui eu tenho um mês de 30 dias, por isso que foi 2. Aqui eu tenho um mês de 31 dias, por isso que foi 1. Isso aqui é justamente para mostrar para vocês que conta até quando vai o mês. Então 25 mais 7 é 1, mês 1, mais 10 porque agora virou o mês, ganhou um mês a mais. Então mais 10, 11 e o ano se mantém 2026. 1 do 11 de 2026. Agora, quando que eu vou usar a data da última menstruação e quando que eu vou usar a primeira ultrassonografia? A gente sabe que na prática clínica isso acontece muito. Então, a gestante fala a data da última menstruação, às vezes ela faz um primeiro ultrassom e existe uma certa divergência. Quando que eu vou considerar essa divergência normal? Então se o ultrassom for realizado entre 7 e 9 semanas, o erro é de mais ou menos 5 dias. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma DUN que deu, por exemplo, 7 semanas e 5 dias, e a idade gestacional pelo ultrassom deu 8 semanas, por exemplo, a diferença foi de 2 dias, eu posso considerar a menstruação. Porque até 5 dias de diferença da menstruação é normal, para mais ou para menos. Aí eu continuo considerando a menstruação. Agora, se a idade gestacional da DUM for menor do que 5 dias da idade gestacional do ultrassom, considere a DUM. Se a idade gestacional da DUM for maior do que 5 dias da idade gestacional do ultrassom, considere o ultrassom. E aí existem outros critérios para as ultrassonografias mais avançadas. Em geral, no primeiro trimestre, a diferença é de 5 a 7 dias. No segundo trimestre, de 7 a 10 dias. Alguns autores consideram até 14 dias. E no terceiro trimestre, a diferença pode chegar a 2, 3 semanas. Entendem por que uma ultrassonografia precoce é importante na datação da gravidez? Porque se eu fizer um ultrassom com 28 semanas, 29 semanas, eu posso ter uma diferença de 2 a 3 semanas do que é a idade gestacional real. E isso pode impactar na minha decisão de indução de parto, de resolução da gestação, tudo isso.

E continuando aqui na amnese, a gente vai falar agora dos sintomas gravídicos do primeiro trimestre, porque vai ter queixa. É difícil uma gestante de primeiro trimestre não ter queixa

nenhuma. Então, a gente pode ter dor na mama, a primeira queixa geralmente que aparece, inclusive, é a dor na mama. Muitas acham que vão menstruar e acaba sendo gravidez, porque a dor na mama aparece ali com 5 semanas de gravidez já. 5 semanas, na verdade, ela tem uma semana de atraso, né gente? Então faz sentido. Cefaleia. Dor de cabeça é comum. Ela pode piorar, pode melhorar, pode ficar igual em relação ao que ela tinha antes da gravidez. Náuseas e vômitos. Mais comum no primeiro trimestre. A gente sabe que tem uma relação com o HCG, com o hormônio HCG. E por isso tem náuseas e vômitos. Fadiga e tontura. Então às vezes ela fica meio sonolenta, cansada, tonta. Tem pirose e cialorreia ou pitilismo. Então pirose é aquela sensação de queimação e cialorreia ou pitilismo é a produção de saliva excessiva, então isso incomoda bastante. Perda ou ganha de peso, então no primeiro trimestre é muito comum perder peso, então não é algo para desesperar porque ela come menos. Diminuição da libido, ela pode falar que no primeiro trimestre ela não tem muita libido. Pode ter sangramento, então sang

Ela pode ter acne e pode ter também variação de humor. Então tudo isso é esperado, mas a gente precisa entender que não é porque é esperado que a gente tem que tolerar, tem que falar para a paciente, ó, fica aí, sente seus sintomas, não faz nada, então a gente tem que orientar as mudanças de estilo de vida, tem que eventualmente passar medicação para essa paciente, para ela não ficar com desconforto, não é porque ela está grávida que ela tem que ficar desconfortável.

E em relação ao ganho de peso? A gente vai sempre considerar o IMC pré-gestacional. E baseado nisso, a gente vai estabelecer quanto de peso essa paciente deve ganhar. Então, em geral, se vocês olharem aqui até 40 semanas, isso aqui é o total que ela vai ganhar durante a gravidez de acordo com o IMC dela. Então é importante saber isso, isso aqui é uma tabela atualizada, a tabela mais atual que a gente tem no Brasil. E é o que a gente espera. Então, não vou entrar em detalhe aqui de quanto que é cada um, isso aqui é para vocês terem ciência, mas é bom memorizar mais ou menos quanto que cada uma dessas mulheres do IMC pré-gestacional poderia ganhar até o final da gravidez, porque eu já vi questão de prova desse jeito.

Alimentação saudável, então a gente já adequa o intervalo, a gente orienta não pular refeições, orienta ingestão de alimentos com ferro, ácido fólico, vitamina D, ômega 3, apesar de muitas vezes ser orientado a suplementação, frutas, legumes, carnes, redução de açúcares, frituras e farinhas brancas, diferente do que a gente faz na nossa prática clínica? Não, né gente? É o que a gente já orienta para todos os pacientes grávidas, não grávidas, adultos, enfim, pessoas gerais recebem uma orientação parecida com essa.

De exercício físico, ela pode fazer? Não só pode, como deve, desde que seja orientado, assistido, adaptado e sem risco de queda. E que tenha para garantir redução de danos e manutenção do peso. Mas a gente deve respeitar contraindicações. Então, é uma paciente que está com colo curto, é uma paciente que tem ciência cardíaca importante, ela tem alguma contraindicação ao exercício físico, aí ela não pode fazer, obviamente. Mas a maior parte das gestantes pode fazer exercício físico, ainda que seja uma caminhada, porque nem toda gestante vai ter a possibilidade de ter uma piscina para fazer uma hidroginástica. Isso aí é para poucas, né, gente? Então, a gente tem que ensinar o exercício mais fácil para essa mulher. E o que? Ela tem condições. E muitas vezes cabe a nós perguntar para essa mulher, quais são as condições, o que você consegue fazer de exercício. Isso é importante.

Exame físico específico. Então a gente vai avaliar mamas e mamilos. A gente vai olhar para os mamilos dessa mulher e ver se eles são preparados para a amamentação. Dependendo, a gente vai orientar alguma massagem, alguma coisa. A altura uterina. A gente avalia os batimentos cardíacos e fetais. E lembrar que com o sonar Doppler, a partir de 12 semanas a gente já consegue escutar. E com o pinar, que é aquele que a gente coloca o ouvidinho na barriga aqui,

que é tipo uma ampulheta, um conezinho assim, que a gente coloca e escuta os batimentos do coração do bebê. Isso é com 20 semanas. Em geral, a gente sente a vibração do batimento fetal. Exame especular e toque vaginal.

E de suplementação, a gente faz ácido fólico e olha que detalhe interessante. De 1 a 3 meses antes da concepção até o fim da gestação. Então sabe aquela consulta pré-concepcional? É nela que a gente vai orientar essa paciente a usar ácido fólico. Quanto? De 0,4 a 0,8 miligramas dia. Ou 400 a 800 microgramas dia. Mas tem um detalhe. Se ela tiver algum fator de risco, como o distúrbio do tubo neural anterior, o que significa isso? Ela teve um filho, por exemplo, com mielomeningocele. Ou ela é diabética. Ou ela é obesa. Ou ela é pós-bariátrica. Ou ela está usando anticonvulsivante, a gente usa dose maior, a gente usa de 4 a 5 miligramas dia, porque nesses casos a gente tem que prevenir realmente o defeito do tubo neural com uma dosagem um pouco maior.

O que mais de suplemento que a gente tem que usar? Sulfato ferroso. O sulfato ferroso é a partir do conhecimento da gravidez até 3 meses pós-parto. Antes, presta atenção, antes, no passado, a gente fazia o sulfato ferroso a partir do segundo trimestre. Então se você tem isso aí na cabeça, mudou. É a partir do conhecimento da gravidez até 3 meses pós-parto. É claro que se ela tiver muitas náuseas, muitos vômitos, eu posso eventualmente suspender o sulfato ferroso do primeiro trimestre. Mas se ela está indo bem, aceitou bem o sulfato ferroso, não teve grande desconforto gastrointestinal, a gente continua desde o primeiro trimestre. Quanto? De 40 a 60 miligramas de ferro por dia. Isso dá 200 a 300 miligramas de sulfato ferroso. Porque a gente tem que dar 40 a 60 miligramas de ferro por dia, ferro elementar. Gente, de suplemento primordial é isso. Existem outros suplementos que são citados na literatura? Existem. Quais? A vitamina D, por exemplo.

Sso aqui é febrasgo, não é Ministério da Saúde. Alguns estudos demonstram diminuição do risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e prematuridade. A Febrasgo recomenda a vitamina D mil unidades por dia e manter a vitamina D entre 30 e 60. Ministério da Saúde se posiciona em relação a isso? Não tem posicionamento, gente. Então é difícil dizer, mas isso aqui é recomendação da Febrasgo.

DHA, que seria o ômega 3, o composto ativo do ômega 3. Então seria 200mg por dia, preferencialmente obtido industrialmente através de algas, se tiver que suplementar, porque ela pode comer peixe o suficiente para ter DHA. Então você pode orientar uma ingestão rica em alimentos originários do mar, mas muitas vezes ela não vai conseguir e por isso às vezes ela tem que suplementar. Isso aqui também fala do mistério? Não fala, mas existe essa recomendação.

Fechou? Presta atenção que agora é uma atualização. Gente, aqui está como se risco de pré-eclâmpsia, mas tem um detalhe, olha que interessante. O Ministério da Saúde se posicionou e hoje o cálcio é obrigatório para todas as gestantes brasileiras. Todas. Todas. Porque o que a gente entende? Que o brasileiro é uma população que não come cálcio suficiente, que não ingere cálcio suficiente. E se existe uma redução do risco de pré-eclâmpsia, toda e qualquer gestante vai receber cálcio.

A partir de quanto? De pelo menos a vigésima semana. Mas idealmente começar na décima segunda semana. Então preste atenção, o cálcio é para todas. Não é somente se houver risco de pré-eclâmpsia. Mas se houver risco de pré-eclâmpsia, aí o cálcio é mais do que obrigatório. Além dele ser precorizado pelo Ministério da Saúde, se houver o risco, ele é fundamental na prevenção da pré-eclâmpsia.

Vocês lembram que as síndromes hipertensivas são a primeira causa de morte materna no nosso país? O intuito de tomar cálcio é também para reduzir isso. Agora, o AS, esse sim, é só para quem

tiver risco de pré-eclâmpsia. E aí na aula de pré-eclâmpsia eu explico isso de forma mais adequada para vocês. Então tem isso na aula de pré-eclâmpsia um pouco mais esmiuçado.

Mas vocês vejam que existe uma redução de pré-eclâmpsia de forma importante. Orientações gerais numa primeira consulta. Ela vai querer saber de relação sexual? Pode ter ou não pode? Se não tiver contraindicação nenhuma, pode. Repouso, tem que fazer? Em geral não. Ela pode seguir a vida dela de uma forma normal, desde que não se coloque em risco.

Constipação intestinal, pode ter? Pode. E aí a gente vai ter que orientar dieta, ingestão de líquido, de fibras. Atividades físicas, pode fazer? Deve. Aquáticas preferencialmente, mas é todo mundo que vai poder? Não. Fumo? Deve fumar? Lógico que não, deve orientar a parar o tabagismo. Álcool? Mesma coisa, deve orientar a parar o etilismo. Drogas ilícitas? Nem se fala, né gente? Medicamentos. Ajustar ali os medicamentos que ela eventualmente já toma.

Adoçantes. Pode tomar adoçante? Pode. Todos os adoçantes são liberados na gravidez. Existem alguns mais estudados? Existem. Então, aspartame, sucralose, são mais estudados, mas eles podem ser utilizados durante a gravidez. Tá certo?

Exame de radiografia pode fazer? A princípio, gente, evitar o primeiro trimestre, mas pesar risco-benefício. A gente tem que lembrar que a mulher também, eventualmente, ela vai precisar de algum exame a mais, porque ela pode ter intercorrências clínicas durante a gravidez. Eu tive um caso recente nesse momento que eu estou gravando aqui de uma gestante que teve uma suspeita de um c renal que não foi visto no ultrassom e eu precisei pedir uma tomografia para ela.

Ela estava grávida de gêmeos e fez a tomografia, e viu lá o cálculo. Então, assim, precisava ter feito para a gente resolver a dor da paciente. Então, nessa situação, a gente eventualmente vai considerar. Profissão, avaliar se oferece algum risco. Vestuário e meias ortopédicas, então orientar que meia elástica é sempre bom. E as viagens de transporte também é uma pergunta que sempre se faz. Então avaliar a questão de companhia aérea quando for viajar de avião, tudo isso.

E orientar que o uso de meia elástica é fundamental para aquelas pacientes que vão se expor a viagens mais longas. E nas consultas subsequentes? Então a gente pergunta sobre os sintomas anteriores e novos sintomas. E aí o que a gente tem de sintoma possível? Fraqueza e desmaio no segundo trimestre, porque é um período que tem hipotensão, dor abdominal, cólica, flatulência, obstipação intestinal, sangramento gengival, dispneia, epistaxe, aumento do número de micções, câimbras, corrimento vaginal, pica ou malássia, que são aqueles desejos esquisitos e esdrúxulos de comer coisas esquisitas, sonolência e o crescimento uterino, que vai gerando um pouco de desconforto.

Segundo trimestre isso. E no terceiro, tem alguma queixa? Tem. Mais comum, né gente? Porque todas elas podem aparecer basicamente em todos os trimestres. Modificação da postura que vai gerar dor lombar, varizes, hemorroidas, cloasma gravítico, que é aquela mancha escura.

Em face, estrias, desconforto para dormir, espinéia, edema, ganho de peso, cansaço. E nas consultas subsequentes, a gente também vai continuar fazendo o exame físico.

A gente vai avaliar o aumento de peso, a gente vai ver os níveis pressóricos. E aí, nos níveis pressóricos, a gente tem que lembrar das doenças hipertensivas. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou diastólica maior ou igual a 90 é hipertensão. Aí pode ser hipertensão crônica, se for antes de 20 semanas ou prévia à gestação. Pode ser hipertensão gestacional, se for após 20 semanas sem preencher critérios para pré-eclâmpsia. Pode ser pré-eclâmpsia, se for após 20 semanas, mais pelo menos um dos seguintes: [critérios para pré-eclâmpsia]. Mas isso também vocês vão ver muito bem na aula de síndromes hipertensivas na gravidez. É só para mostrar que isso faz parte da nossa consulta pré-natal e do diagnóstico durante a consulta.



A altura uterina. Aqui, nas consultas subsequentes, a altura uterina, como é que a gente faz? A gente pega o bordo superior da sínfise púbica, vai até o útero, coloca a mãozinha perpendicular ao fundo uterino e mede quanto que deu isso. A altura uterina a gente vai jogar numa tabela e a gente vai ver se está dentro do percentil 10 e 90 e vai ver a curva de crescimento dessa barriga, para ter uma noção se o neném está seguindo a mesma curva.

Agora tem um detalhe interessante. Existe um jeito de a gente calcular mais ou menos a idade gestacional baseada na altura uterina? Existe. Então, imaginem vocês. Uma paciente sofreu um acidente, ela está desacordada e ela tem uma barriga de grávida. Você mede essa barriga e se tem só a altura uterina. Você pode fazer a regra de McDonald's aqui. A idade gestacional vai ser a altura uterina vezes oito sétimos. E aí você consegue ter uma estimativa de qual é a idade gestacional dessa paciente.

Vamos ver um exemplo aqui de alteração de altura uterina? Então eu tenho aqui o gráfico e nesse gráfico eu tenho uma altura uterina que está aqui. Então está abaixo do percentil 10. É uma gestante que tem 33 semanas de gestação que está com uma altura uterina de 25. O que pode ser isso, gente? Então se está abaixo do percentil 10, o que eu vou pensar? Qual é a hipótese diagnóstica? Posso pensar que tem pouco líquido? Posso. Aí a barriga fica menor. Posso pensar que tem um erro de data? Também posso. Errei a data, calculei errado. De repente não é aquela idade gestacional que eu coloquei no gráfico. Então tem que recalcular. Pode ser uma restrição de crescimento hidrótico? Pode, o neném cresceu pouco e por isso está ficando menor a barriga. E qual seria a conduta? Uma ultrassonografia obstétrica.

Então se eu vi que uma barriga está menor do que esperado para a idade gestacional, eu faço uma ultrassonografia. Só que tem um detalhe. Se eu encontro uma ultrassonografia normal, se o feto está normal, Dentro do percentil esperado, entre 10 e 90. E se o líquido está normal, eu considero essa ultrassonografia normal. E eu não considero uma restrição de crescimento. Então a altura uterina é um exame meio que de rastreio. Eu vou observar e imaginar hipóteses. Mas a ultrassonografia é que vale confirmar se existe uma restrição ou não.

E se na curva tivesse maior do que o percentil 90? O que eu poderia pensar? Posso pensar em polidramiame, então tem mais líquido do que o esperado. Posso pensar num feto grande para a idade gestacional, que é um feto não necessariamente macrossômico, significa que ele está crescendo mais rápido do que eu esperado, acima do percentil 90. Mas pode ser também um erro de data. E lembrando, se o transom vier normal, eu considero normal.

O que mais? Manobra de Leopold Zweifel. Então isso faz parte do exame físico também, vocês lembram dela? São quatro manobras. Então eu vejo aqui qual que é o polo do feto que está aqui em cima, no fundo uterino. Eu jogo as mãos para a lateral e vejo onde está o dorso, onde estão os membros. Aí eu vejo qual que é o polo que está aqui embaixo, vejo se ele está móvel ou insinuado. Então através dessas duas manobras eu vou ver qual que é o polo que está apresentando. Então é o polo pélvico ou é o polo cefálico ou é o córmico. E eu vejo também se existe mobilidade, se é um feto que já está encaixado ou não.

Lembrando que essa quarta manobra, o examinador vira de costas para a paciente para fazer o exame. Então essa quarta manobra é diferente. Enquanto a gente está fazendo a palpação da paciente, sempre à direita da paciente, aqui a gente faz essa palpação com as costas para a paciente. Fechou?

Então, consultas subsequentes. O que mais que a gente faz, além da manobra de Leopold Zweifel? Avalie movimentação fetal. Então, geralmente vai começar entre 19 e 20 semanas. Mas a gente vai sentir entre 19 e 20 semanas? Não. Quem sente é a mulher. A gente vai sentir um

pouquinho mais adiante. Os batimentos cardíacos fetais. Consigo escutar? Consigo. Lembrar daquela história do sonar dupla até 12 semanas e do pinar a partir de 20 semanas. Sonar dupla até 12 semanas e do pinar a partir de 20 semanas.

Aqui está o texto pontuado e organizado em parágrafos:

A partir de 12 semanas e hipnar a partir de 20 semanas. Avalio também edema. Essa mulher já está inchando ou não? O que mais que eu faço durante o pré-natal?

Eu faço imunização, eu vou preconizar vacinas para essa mulher. Quais vacinas que são preconizadas? Influenza, hepatite B, difteria tétano e coqueluche, a celular, coronavírus e agora, mais recentemente, o vírus essencial respiratório.

Como é que funciona? Vacina de influenza. Ela é aplicada em qualquer trimestre, então pode aplicar no primeiro trimestre? Pode. É uma dose única anual e se a gestante foi imunodeprimida, eu posso considerar uma segunda dose a partir de 3 meses após a dose anual. E um detalhe é que ela é gratuita no SUS.

Hepatite B, eu vejo se ela tem história vacinal. Já foi vacinada em 3 doses? Se já foi, em geral eu não vacino de novo, a não ser que ela seja um extremo grupo de risco. Porque eu não vou esperar, se ela não está exposta ao vírus, que ela tem título de anticorpos elevados.

Deu dúvida se ela foi vacinada? Você pode fazer o que a gente chama de dose booster, dose desafio. Você faz uma dose da vacina, em 30 dias você coleta o anti-HBS. Se o anti-HBS estiver estourado, estiver super positivo, significa que ela já foi imunizada.

Faço essa vacina também em qualquer trimestre. A vacina são três doses, então eu faço zero, um mês após e seis meses após a primeira dose. E ela também é gratuita no Sistema Único de Saúde.

DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche. A gente tem cenários possíveis. Então essa paciente já tomou três doses de vacina do tétano. Então, ela vai tomar somente uma dose a partir da vigésima semana de gestação, de DTPA.

Ela tem a vacina incompleta, falta só uma dose, ela vai completar essa dose já com uma DTPA. Então, perdão, aqui ela tomou só uma dose na vida. Então, se ela tomou só uma dose na vida, ela precisa fazer mais duas doses. Sendo que ela vai fazer uma dose de DT e uma dose de DTPA a partir da vigésima semana.

E tem que ter no mínimo um mês entre elas. Se ela tem duas doses tomadas, né? Então, se ela já tomou duas doses, eu vou fazer só uma dose de DTPA, porque com isso eu completo o esquema e garanto o componente perturce.

O objetivo dessa vacina é prevenir coqueluche e tétano neonatal e nos recém-nascidos, tá? Então, a ideia aqui de vacinar essa gestante é pra isso. E se ela não for vacinada ou não tiver histórico vacinal, A gente faz duas doses de DT e uma dose de DTPA a partir da vigésima semana.

A DTPA tem que ser sempre a partir da vigésima semana. O tétano não pode ser aplicado inclusive no primeiro trimestre. Lembrando que o intervalo mínimo é de um mês entre elas. Mulheres não vacinadas na gestação podem ser vacinadas no puerpério até 45 dias pós-parto. O mais precocemente possível.

Um detalhe importante aqui, gente, é que essa mulher deve ser vacinada em toda e qualquer gestação. Então, se ela foi vacinada agora e engravidou de novo daqui a um mês, então ganhou o neném ali. Um mês depois ela engravidou. Raro, mas pode acontecer.

Um mês depois ela engravidou, ela vai tomar outra dose de DTPA, independentemente do histórico vacinal dela. E essa vacina também é gratuita no SUS. Coronavírus. Tem que tomar ainda corona? Tem. Por dois motivos. Primeiro porque protege a mãe e segundo porque protege o bebê.

Hoje uma das grandes causas de internação de recém-nascidos e de bebês até seis meses de idade é o coronavírus. E está matando os bebezinhos. Então, vacinar a gestante também faz com que haja uma passagem de anticorpos pela placenta e esse bebê nasça mais protegido contra o coronavírus.

Então, o objetivo agora também é a proteção do bebê. É uma vacina que é feita anualmente e a cada gestação e ela também é gratuita. E essa vacina está disponível somente na rede pública. Se você quiser na rede privada, você não vai encontrar. Não existe essa vacina na rede privada.

Então, tem que orientar ela a tomar na rede pública sempre. Vírus essencial respiratório. Vacina recém-aprovada pela Conitec. Então, é uma vacina nova que previne bronquiolite nos bebezinhos. A vacina que é disponível para isso é a Brisvo, é a única vacina disponível para aplicação na gestante.

Então, essa é a vacina que deve ser feita. Ela é uma dose intramuscular a partir de 28 semanas de gravidez. Indicada em qualquer momento, independentemente da sazonalidade. E ela foi licenciada pela Anvisa a partir de 24 semanas. Então, eventualmente, você pode antecipar a vacinação para antes de 28 semanas, se for necessário.

Mas, a princípio, a recomendação é que ela seja aplicada a partir de 28 semanas de gravidez. Vacinas em situações especiais. Febre amarela, raiva, hepatite A, pneumocócica, meningocócica e meningocócica B.

Febre amarela, por que tem dois asteriscos? Porque a febre amarela, gente, ela é uma vacina que a princípio é contraindicada. Mas se eu estou num cenário em que eu tenho um surto de febre amarela, eu posso indicar a vacina contra a febre amarela. Então, está rolando muita morte de pessoas com febre amarela. Eu vou deixar minha gestação...

Ante susceptível a febre amarela? Não. Se ela não tiver histórico vacinal, eu tenho que vaciná-la. Lembrando que hoje a febre amarela é uma dose durante a vida toda se ela tiver tomada a dose plena. Raiva. Se ela tiver alguma exposição, Hepatite A. Se ela tiver risco a se ela não tiver imunidade, por exemplo. No SUS não existe essa recomendação ainda, mas pode ser considerada para aquela que queira eventualmente pagar pela vacina. Alguns grupos especiais, por exemplo, imunossuprimidos, têm indicação da vacina durante a gravidez. A mesma coisa para a pneumocócica, meningocócica, etc. E em relação às imunoglobulinas em situações especiais, se ela tiver um contato com alguém que tenha catapora e ela nunca teve catapora na vida ou não foi vacinada, ela tem que fazer imunoglobulina até 72 horas após o contato. Se a exposição foi com sarampo e ela também não é vacinada, até 6 dias do contato. Se ela teve uma exposição a hepatite B, a gente faz a imunoglobulina mais a vacina. Raiva, se ela tiver tido uma exposição que precise de imunoglobulina. Tétano, mesma coisa. Imagina uma perfuração por prego, enferrujado, aquela história toda. E lembrar que se ela for RH negativo, tiver cúmbis indireto negativo, e o pai for RH positivo, e por isso o feto tem possibilidade de ser RH positivo, tem que fazer a imunoglobulina anti-RH. Então algumas imunizações relacionadas à imunoglobulina. E de vacina contraindicada. HPV, triplice viral, varicela, dengue, febre amarela. Por que a febre amarela entrou aqui de novo? Justamente por isso, porque ela é contraindicada se eu não estiver num cenário de risco. Se eu estiver num cenário em que essa gestante não tem risco de febre amarela, a princípio eu não vacino essa mulher. A poliomielite oral também é proibida, é proscrita, melhor dizendo. E a

BCG também. Vejam que isso aqui são coisas que tem vírus atenuado, muitos deles. Então vírus ou bactérias, enfim. Então a gente não tem recomendação de fazer na gravidez.

De exames complementares, o que a gente vai fazer? Então no primeiro trimestre, vou fazer hemograma e ferritina sérica. A ferritina, gente, isso aqui é controverso, tá? O Ministério da Saúde não coloca a ferritina como exame primordial. Então presta atenção no que eu estou falando. O Ministério da Saúde não coloca a ferritina. Mas cada vez mais existe a recomendação da gente dosar a ferritina. Porque se ela tiver uma deficiência de ferro, isso vai ser importante para a gente repor o ferro de uma forma diferente. Faz tipagem a BORH e faz cumbis indiretos, principalmente se ela for RH negativo. Faz uma glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é obrigatória para todas? Também não. Faz a glicemia de jejum que é o principal. Urina 1, urocultura e antibiograma. E o TSH. O que o Ministério da Saúde fala? Que o TSH, se a gente tiver disponibilidade, for um exame fácil, acessível, a gente pode recomendar e pode fazer. Mas é obrigatório? Não. E a ferritina eu coloquei de novo porque ela é interrogada. É aquilo que eu falei ali em cima, tá? Então não necessariamente vai fazer a ferritina.

De exames sorológicos, teste rápido para sífilis, teste rápido para HIV e anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG, hepatite B, que a gente faz o HBS e a G, se o HBS e a G tiver negativo, a princípio eu não preciso continuar a investigação, mas a gente tem que ver também se essa paciente tem história vacinal contra a hepatite B, porque se não tiver, ela precisa ser vacinada na gravidez. Hepatite C entrou no calendário das sorologias a serem pedidas para a gestante, porque se a gente faz o diagnóstico, ela pode ser encaminhada para o tratamento após o término da gravidez. Rubela, a gente pede principalmente para ver se ela tem imunidade, se ela tem IgG. Se ela não tiver IgG, a gente orienta a vacinação após o término da gravidez. Sorologia para citomegalovírus é super controversa, Mas a gente, se tiver disponível, pode solicitar. HTLV virou obrigatório pelo Ministério da Saúde também. Então HTLV a gente coleta para toda e qualquer gestante, porque a gente tem que suspender a amamentação se ela tiver o HTLV positivo. E a gente pode testar o IgG para parvovírus B19 para pessoas específicas, professores de escolas ou funcionários de creches, devido à associação dele com hidropsia fetal não imune.

O que é hidropsia fetal não imune? Esse feto faz uma anemia grave e ele faz uma anasarca, ele faz um edema e esse edema é conhecido como hidropsia fetal. É um quadro grave que pode inclusive levar a óbito. Quando a gente tem uma gestante com mais de 30 anos, eu também devo fazer uma pesquisa de clamídia e gonococo para essa mulher. Então, tem mais de 30 anos, pesquisa de clamídia e gonococo para essa mulher. Não obrigatórios, compostologia oncótica, então isso é se necessário, se tiver na janela de oportunidade. Lembrar que o Ministério da Saúde incorporou recentemente a pesquisa molecular para o HPV, então, a depender do local onde estiver esse HPV já vai ser a forma como deve ser investigada essa questão do colo uterino.

O uterino. Exame de secreção vaginal, se necessário. Parasitológico de fezes também não é recomendado para todo mundo, se ela tiver uma história, se ela tiver um fator de risco, se ela tiver uma anemia que não melhora. Eletroforese de hemoglobina, se tiver uma história de anemia que não melhora, se tiver história familiar, por exemplo, de anemia falciforme ou de traço falcêmico.

A gente pede uma proteinúria para que elas são hipertensas de base, justamente para poder comparar lá na frente. Com pré-eclâmpsia, para aquelas pacientes que fizeram pré-eclâmpsia. E eu posso pedir gota espessa naquelas que forem regiões endêmicas para malária. O que mais que a gente pede no segundo trimestre?

TOTG 75 gramas, se a glicemia for abaixo de 92. Então, se eu fiz a glicose lá do começo e deu abaixo de 92, ela não tem diabetes lá naquele começo. Então eu peço entre 24 e 28 semanas. Peço um cumbis indireto, se o RH for negativo. E peço um eco fetal. Então se ela tiver uma história

familiar de cardiopatia, se tiver uma idade materna maior do que 35 anos, enfim, tem alguns critérios.

Isso aqui é uma complexidade grande, porque há pouco tempo surgiu uma lei que falava que toda paciente devia fazer eco cardiograma, mas fetal no caso, e aí virou um bafafá porque as sociedades se manifestaram, a febrássica se manifestou. E assim, gente, o que a princípio tem de recomendação é que a gente faça nesses grupos aqui, tá?

No terceiro trimestre, o que a gente vai fazer? Um hemograma, cumbis indireto, CRH negativo, sífilis, HIV, um teste rápido. Então a gente repete meio que as serologias. Hepatite B, a gente pode pedir o HBS-AG, tá? De novo. Toxoplasmose, se ela for susceptível. Urina 1, urocultura. Lembrando que a toxo, gente, o ideal é que a gente faça de forma mensal, tá? Então todos os meses a gente vai avaliando a toxo.

Algumas coisas aqui, a gente tem questões específicas que a gente discute ao longo das aulas específicas para cada um desses temas, tá? E lembrar que 36 a 37 semanas e 6 dias a gente deve fazer o teste também, que é o estreptococcus do grupo B.

E quais são as indicações da ultrassonografia? Então é importante, gente, a ultrassonografia. Então a gente serve para datar a gestação, serve para localizar o número de sacos gestacionais, serve para avaliar a vitalidade embrionária, está vivo ou não está esse neném. A gente avalia sinais de mal prognóstico, avalia os anexos e faz uma avaliação de sangramento de primeiro trimestre.

Então a ultrassonografia tem uma grande importância hoje. É difícil a gente viver hoje, fazer um pré-natal, fazer um atendimento obstétrico de qualidade sem a ultrassonografia. Ela é fundamental. Entendo que mesmo a febrasgo se posicionando, a gente sabe que tem que ter pelo menos 3 ultrassonografias ao longo da gravidez. Então seria um morfológico de primeiro trimestre, um morfológico de segundo e aí um exame pelo menos no terceiro trimestre. Mínimo, pelo que é preconizado no Brasil.

O Ministério fala que não é um exame obrigatório e a gente compreende isso, porque você está falando de um protocolo que vai ser utilizado no país todo. Mas ele fala também que se você tem disponível isso como método complementar, que você faça. Bom, sim, a gente deve fazer.

Então, no primeiro trimestre, de 6 a 9 semanas, a gente faz via vaginal. Depois de 11 a 14 semanas, quando a gente tem um comprimento cabeça nádega de 45 a 84 milímetros, a gente faz via abdominal com Doppler, para avaliação do morfológico, né? Esse aqui seria o morfológico.

No segundo trimestre, de 18 a 24 semanas, a gente faz o morfológico também, para avaliar a malformação e cromossomopatias. E no terceiro trimestre, a gente deveria fazer um entre 34 e 36 semanas, para avaliar crescimento fetal, dopre, perfil biofísico fetal, dentre outras coisas. Então isso aqui seria um ideal, um cenário ideal, pelo menos 4 tracionografias. 3 é o mínimo, mas a gente pode considerar um quadro como esse aqui como o ideal para a gente fazer.

E aí tem o plano de parto, gente. O plano de parto é uma coisa interessante para discutir durante o pré-natal. Ele é o primeiro de uma série de recomendações da OMS que fala um passo a passo do parto. Essa mulher vai ser orientada de como ela gostaria que o parto dela fosse. Então o objetivo é evitar imprevistos de difícil solução.

Então você imagina, essa mulher vai chegar no hospital, o médico que vai atender ela não a conhece, mas ela quer demonstrar quais são os desejos dela em relação ao parto. Então isso garante que ela seja protagonista desse momento. E aí a gente tem as preferências claras do que ela quer para a equipe. E ele é um documento norteador das escolhas da mulher. Ele não é um

documento obrigatório. Não é porque ela quer que seja feito aquilo que obrigatoriamente será feito aquilo. Ele é norteador.

Eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que seja assado. Mas virou uma situação de emergência, a gente tem que discutir com a mulher. Olha, eu sei que você gostaria que fosse assim, mas se a gente não fizer assim, a gente tem que explicar por quê.

Guma coisa neste momento, seu bebê pode morrer ou você pode morrer. Enfim, então existem mudanças que podem ser feitas ao longo do processo. Fechou? E, para finalizar, eu trago mais uma atualização que é mega importante, que vale a pena discutir em toda e qualquer consulta pré-natal. Vem conferir.

O que eu quero falar, gente, é o conceito de epigenética. Vocês já ouviram falar nisso? Epigenética é um conceito simples. Eu tenho o DNA, eu tenho o cromossomo e eu tenho meus genes ali naquele DNA. Então, eu, Fabiano, nasci com aqueles genes ali. Mas desde o momento intraútero, de acordo com a exposição que eu tenho intraútero, então se eu sou o filho de uma mulher que é obesa, hipertensa, diabética, que come super mal, que não faz exercício físico, isso me predispõe a determinadas doenças no futuro. Por quê? Qual que é o conceito de epigenética?

Eu tenho o gene, mas eu posso ligar ou desligar esse gene de acordo com o ambiente que está sendo formado ali. Então, é como se eu expressasse ou não esse gene. Então, isso o ambiente determina essa expressão ou não gênica. Então é muito importante que a gente oriente que o que essa mulher faz durante a gravidez pode repercutir durante toda a vida desse bebê, dessa criança, desse adulto e até a idade mais velha lá, a velhice mesmo. Então, o que ela faz com esse bebê intraútero pode repercutir ao longo de toda a vida.

E isso fica o conceito para vocês também. É importante que a gente olhe com carinho, para a gente também. Porque a gente também pode determinar a manifestação ou não de determinados genes ao longo da nossa vida. Mas principalmente nessa fase intrauterina. Fechou?

Quais são os principais pontos a serem abordados durante uma gestação de baixo risco? Eu conversei com vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula meio extensa, às vezes até um pouco chata, eu sei disso, mas ela é super importante porque ela chove nas provas. Tem que saber assistência pré-natal. Existe mais uma aula na qual eu vou falar sobre as intercorrências relacionadas ao pré-natal. Seria um aprofundamento dessa aula, porque não dá pra falar tudo de assistência pré-natal, o que a gente faz em nove meses em apenas uma aula.

Combinado, gente? Vejo vocês numa próxima. Até lá!

### 3. TRANSCRIÇÃO ORIGINAL (BRUTA)

Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula desse nosso curso mega importante para você garantir a sua prova aí, para ser aprovado, é tudo que a gente espera e é o que a gente quer. Quais são os principais pontos a serem abordados durante uma gestação de baixo risco? Será que você sabe me dizer? Nós vamos abordar isso hoje na assistência pré-natal. Então essa é uma aula super importante, é tema de prova frequente e vocês têm que saber. Qual que é o objetivo da assistência pré-natal, então? A gente tem alguns objetivos. O primeiro deles é diagnosticar e confirmar a gravidez, que a gente pode fazer pelo teste rápido, um teste de urina. A gente diagnostica doenças pré-existentes. Aqui, idealmente, é que ela tivesse feito algo pré-concepcional, antes mesmo de iniciar o pré-natal. Proporciona a rigidez ao organismo materno e fetal, ou pelo menos tenta, porque na verdade nem sempre a gente vai conseguir. E ampara socialmente e psicologicamente essa paciente. Prepara para o parto e para a maternidade. E cuida da parceria. A parceria é o parceiro mesmo, o marido ou a esposa, né? Enfim, a gente precisa também ter esse cuidado e fazer o pré-natal da parceria também, porque isso também vai contribuir ali, tanto para a assistência pré-natal, quanto para o momento pós-parto. E para finalizar os objetivos, a gente orienta os direitos previstos em lei. Então, quanto de licença maternidade, o que pode fazer, se pode afastar, se não pode, enfim, detalhes de direitos previstos e lei também acaba sendo um pouco de nossa responsabilidade. E qual que é o ideal de consultas? Então, antes de mais nada, o ideal é que a gente faça uma consulta pré-concepcional. Então, essa mulher deveria passar em consulta médica conosco para a gente solicitar vários exames. Quais são eles? Então sorologia, para avaliar as vacinas que ela pode tomar, porque existem vacinas que não podem ser feitas na gravidez, mas que valem a pena serem feitas antes de engravidar, para aquelas que não tem o cartão vacinal, por exemplo, atualizado. A gente avalia as doenças e além de avaliar as doenças, a gente ajusta as medicações, obviamente. Avaliar os hábitos de alimentação, o ideal é que essa paciente faça exercício físico, que ela se alimente de forma adequada. A questão dos medicamentos que eu acabei dizendo nas comorbidades, então a gente ajusta. Será que ela toma algum medicamento que não pode ser tomado durante a gravidez? Nós vamos ajustar isso. E a gente avalia as condições de trabalho. Será que ela tem alguma condição no trabalho que possa ser prejudicial para uma gestação? E aí a gente vai orientá-la em relação a isso. E avalia o parceiro. O parceiro também é muito importante no processo. O parceiro saudável também ajuda, contribui para uma gestação saudável. E se a gente for pensar em primeira consulta, quando que deve ser a primeira consulta de uma paciente que descobriu a gravidez? No primeiro trimestre, o mais precocemente possível. E aí nesse momento também a gente determina aquelas que vão precisar de acompanhamento especializado. É uma gestação de alto risco que eu preciso encaminhá-la para algum serviço ou para um pré-natal de alto risco? Então, nesse momento, é a hora da gente decidir se essa paciente procura, procura não, é encaminhada ou não a um serviço de maior complexidade. Números de consultas. Então, a gente tem duas formas de analisar. Pelo Ministério da Saúde, que é o principal, que cai na prova de vocês, é um mínimo de seis. Seria uma consulta no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre. Mas vamos pensar num cenário ideal, qual seria o ideal para a gente ter de consulta pré-natal? Numa paciente de baixo risco. A gente conduzia essa paciente até a 28ª semana de forma mensal, da 28ª até a 36ª semana quinzenal e da 36ª até a 41ª de forma semanal. Lembrando que não existe alta do pré-natal. Então se voltar uma mulher para o posto de saúde, para a UBS, dizendo que não entrou em trabalho de parto, que não ganhou o bebê e quiser marcar uma consulta e ela está grávida, tem que marcar, porque ela não tem alta até o nascimento. E o cuidado continua, inclusive após o nascimento. Nasceu, ela volta para o puerpério, para as primeiras consultas ali de puerpério. Lembrando que 90% das pacientes serão de baixo risco, se a gente for pensar em sistema único

de saúde, o segmento vai ser na atenção básica. Somente 10% das pacientes vão ter alguma doença pré-existente para caracterizar alto risco. Ou que tem uma história reprodutiva com mal passado obstétrico, por exemplo, com perda fetal tardia, com algum cenário triste. Uma história triste que faça com que a gente encaminhe para o alto risco. Alterações fetais e maternas na gestação atual. Então, imaginem vocês que ela faz, por exemplo, uma restrição de crescimento intrauterino. Vou encaminhá-la para o alto risco. Fez pré-eclâmpsea, vai para o alto risco. Então, essas pacientes precisam ser cuidadas num serviço especializado. E aí, quando ela chega na primeira consulta, a gente vai logo para a anamnese. Então, a gente identifica essa paciente, pede dados socioeconômicos, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, Antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos e analisa a gestação atual. Isso aqui, gente, é anamnese. É anamnese básica, então a gente tem que fazer para toda e qualquer paciente, mas na história de uma gestante, a gente vai incluir aqui ginecológicos, obstétricos e a gestação atual também, de uma forma a avaliá-la adequadamente. E em toda consulta é importante que a gente faça esse método mnemônico aqui, que seria o DOM, DOP, ADOP, DCC e DG. O que é isso? Dom, diagnóstico obstétrico de normalidade. Então como é que está essa gestação? É uma primigesta? É uma secundigesta? Qual é a idade gestacional dela? Dopa, diagnóstico obstétrico patológico atual. Tem algum problema de saúde nessa gestação? Por exemplo, DMG, diabetes mellitus gestacional. Entraria aqui no Dopa. Dope, diagnóstico obstétrico patológico pregresso. Então não teve DMG nessa gestação, mas teve na gestação anterior. Entraria aqui. Diagnóstico clínico cirúrgico. Então tem alguma coisa, por exemplo, ela é hipertensa crônica de base, porque não é um quadro obstétrico. Ela é hipertensa crônica de base, entraria aqui. E diagnóstico ginecológico, seria alguma alteração ginecológica que ela eventualmente tenha. E por que o pré-natal é tão importante? Por que a gente faz pré-natal, gente? Porque a gente tem que reduzir a mortalidade materna e melhorar desfecho, tanto materno quanto fetal. A gente quer recém-nascidos com saúde e a gente quer, ao final, também que as mulheres também tenham saúde. E aí a gente precisa lembrar que as principais causas de morte no Brasil são essas. Hipertensão é em primeiro lugar, hemorragia é em segundo lugar e infecção é em terceiro lugar. Isso é muito importante dizer porque a gente vai ter que olhar com carinho para esses três cenários. Então, a gente vai ter que prevenir a doença hipertensiva, a gente vai ter que prevenir hemorragia pós-parto e tratar a hemorragia pós-parto de forma oportuna, e a gente tem que prevenir e tratar a infecção quando for diagnosticada. Prematuridade é aquele nascimento que acontece antes de 37 semanas. Então, de 75% a 95% das taxas de óbito neonatal não associadas a malformações congênitas. Então vocês vejam, os bebês morrem, óbito neonatal, quando não é malformação congênita, principalmente por prematuridade. Então isso é um negócio que a gente tem que diminuir também. Então o que a gente quer é um bebê saudável. Ainda assim, o melhor que a gente faça o pré-natal, vez ou outra, a gente vai ter um parto prematuro. Acontece. Mas a gente tem que minimizar as possibilidades dessa prematuridade acontecer. Então a gente tem que ficar atento também ao histórico de perdas gestacionais e prematuridade prévia. Porque a gente já sabe que o principal fator de risco para ter um parto prematuro é ter tido um parto prematuro anterior. Esse é de longe o principal fator de risco. Então a história obstétrica é importante. Vocês lembram daquele diagnóstico patológico obstétrico pregresso? Essa paciente precisa falar que ela teve um parto prematuro anterior, porque isso muda o prognóstico e muda inclusive a avaliação dessa paciente. Mas a gente também nessa anamnese tem que calcular a idade gestacional dessa paciente. Então a gente vai pegar ali a data da última menstruação, a famosa DUM, que vocês já devem estar cansados de saber, e calcular qual vai ser a data provável do parto. Sendo que a data provável do parto não é a data que o neném vai nascer, gente. O que significa data provável do parto? É quando essa paciente completa 40 semanas de gravidez. Então, se a gente for pensar que o termo começa com 37 semanas e as gestações de baixo risco podem ir até 41 semanas, esse bebê, em teoria, se ele



for nascer num período saudável, ele vai até 41 semanas. Na verdade, se a gente for conceitualmente falar mesmo, é até 42 semanas. É que os protocolos atuais a gente interrompe com 41 semanas, que pode ser um parto induzido, inclusive. Mas normalmente de 37 a 41, tá? E aí é 40 semanas, então não é a maioria dos partos que vai acontecer nas 40 semanas. Aliás, é a minoria, se a gente for pensar que a gente tem várias semanas pra esse bebê nascer, poucos partos vão acontecer nas 40 semanas exatas. Então é só pra vocês saberem que isso aqui é uma estimativa, é uma noção de quando mais ou menos vai ser o parto dessa paciente. E aí como é que a gente pode calcular essa data provável do parto? A gente pode utilizar o que a gente chama de regra de Neigeli. Essa regra é o seguinte, se essa mulher, se a data da última menstruação dessa mulher foi em janeiro, fevereiro ou março, eu somo sete dias da data do dia dessa última menstruação e somo nove meses. Eu vou dar exemplo, gente, porque eu sei que é difícil entender isso. E se a data da última menstruação foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu somo 7 dias, diminuo 3 meses e somo 1 ano. Vamos entender como é que fica isso? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Fica bem mais fácil de compreender quando a gente vê esses números. Então vamos imaginar uma paciente que tem a data da última menstruação de 15 de dezembro de 25. Como é que eu vou calcular DPP? Eu pego os 15, que é o dia, somo 7, vai dar 22. Como o mês foi dezembro, eu vou subtrair 3. 12 menos 3 igual a 9. O ano é de 2025. Vocês concordam que não vai nascer em 2025? Ela engravidou em dezembro de 2025. Não vai nascer em 2025. Então, tem que virar o ano para 2026. DPP 22 do 9 de 26. Agora, se a DUM foi 2 do 3 de 26. Vamos lá. Dia 2 mais 7, 9. O mês agora, como foi março, eu vou somar 9. Então 9 mais 3, 12. E o ano se mantém, porque ela engravidou em março e vai nascer a princípio no mesmo ano. 2, cadê? 9 de dezembro de 2026. Então ficou no mesmo ano. E é óbvio, né gente? Porque assim, 2 de março de 2026. Eu não posso virar o ano para 2027 e nascer 9 de dezembro de 2027. Não é gestação de elefante isso aqui. Então também tem que ter um pouquinho de lógica para compreender, sabe? Então é mais 7 e mais 9 se for até março e menos 3 se for de abril em diante. Mas aí tem esse cenário, né? E quando vira o mês? Então vamos pensar aqui, 25 do 4 de 25. Na hora que eu somo 7, virou 2. Mas vocês concordam que isso aqui virou o mês? Na hora que vira o mês, em vez de eu subtrair 3, eu vou subtrair 2. E aí o ano de 2025 mais 1 de 2026, 2 do 2 de 2026. E se a DUM for 25 do 1 de 26, por exemplo? 25 mais 7 é 1, porque aqui eu tenho um mês de 30 dias, por isso que foi 2. Aqui eu tenho um mês de 31 dias, por isso que foi 1. Isso aqui é justamente para mostrar para vocês que conta até quando vai o mês. Ent 25 mais 7 1 m 1 mais 10 porque agora virou o m ent ganhou um m a mais Ent mais 10 11 e o ano se mant 2026 1 do 11 de 2026. Agora, quando que eu vou usar a data da última menstruação e quando que eu vou usar a primeira ultrassonografia? A gente sabe que na prática clínica isso acontece muito. Então, a gestante fala a data da última menstruação, às vezes ela faz um primeiro ultrassom e existe uma certa divergência. Quando que eu vou considerar essa divergência normal? Então se o ultrassom for realizado entre 7 e 9 semanas, o erro é de mais ou menos 5 dias. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma DUN que deu, por exemplo, 7 semanas e 5 dias, e a idade gestacional pelo ultrassom deu 8 semanas, por exemplo, a diferença foi de 2 dias, eu posso considerar a menstruação. Porque até 5 dias de diferença da menstruação é normal, para mais ou para menos. Aí eu continuo considerando a menstruação. Agora, se a idade gestacional da DUM for menor do que 5 dias da idade gestacional do ultrassom, considere a DUM. Se a idade gestacional da DUM for maior do que 5 dias da idade gestacional do ultrassom, considere o ultrassom. E aí existem outros critérios para as ultrassonografias mais avançadas. Em geral, no primeiro trimestre, a diferença é de 5 a 7 dias. No segundo trimestre, de 7 a 10 dias. Alguns autores consideram até 14 dias. E no terceiro trimestre, a diferença pode chegar a 2, 3 semanas. Entendem por que uma ultrassonografia precoce é importante na datação da gravidez? Porque se eu fizer um ultrassom com 28 semanas, 29 semanas, eu posso ter uma diferença de 2 a 3 semanas do que é a idade gestacional real. E

isso pode impactar na minha decisão de indução de parto, de resolução da gestação, tudo isso. E continuando aqui na amnese, a gente vai falar agora dos sintomas gravídicos do primeiro trimestre, porque vai ter queixa. É difícil uma gestante de primeiro trimestre não ter queixa nenhuma. Então, a gente pode ter dor na mama, a primeira queixa geralmente que aparece, inclusive, é a dor na mama. Muitas acham que vão menstruar e acaba sendo gravidez, porque a dor na mama aparece ali com 5 semanas de gravidez já. 5 semanas, na verdade, ela tem uma semana de atraso, né gente? Então faz sentido. Cefaleia. Dor de cabeça é comum. Ela pode piorar, pode melhorar, pode ficar igual em relação ao que ela tinha antes da gravidez. Náuseas e vômitos. Mais comum no primeiro trimestre. A gente sabe que tem uma relação com o HCG, com o hormônio HCG. E por isso tem náuseas e vômitos. Fadiga e tontura. Então às vezes ela fica meio sonolenta, cansada, tonta. Tem pirose e cialorreia ou pitilismo. Então pirose é aquela sensação de queimação e cialorreia ou pitilismo é a produção de saliva excessiva, então isso incomoda bastante. Perda ou ganho de peso, então no primeiro trimestre é muito comum perder peso, então não é algo para desesperar porque ela come menos. Diminuição da libido, ela pode falar que no primeiro trimestre ela não tem muita libido. Pode ter sangramento, então sangramento geralmente vaginal é frequente no primeiro trimestre em até 50% das vezes. 50% das gestantes vão ter algum sangramento no primeiro trimestre de gravidez. A diurese fica mais frequente, primeiro por alterações hormonais e depois porque o útero se repousa sobre a bexiga e acaba fazendo uma compressão. Ela pode ter acne e pode ter também variação de humor. Então tudo isso é esperado, mas a gente precisa entender que não é porque é esperado que a gente tem que tolerar, tem que falar para a paciente, ó, fica aí, sente seus sintomas, não faz nada, então a gente tem que orientar as mudanças de estilo de vida, tem que eventualmente passar medicação para essa paciente, para ela não ficar com desconforto, não é porque ela está grávida que ela tem que ficar desconfortável. E em relação ao ganho de peso? A gente vai sempre considerar o IMC pré-gestacional. E baseado nisso, a gente vai estabelecer quanto de peso essa paciente deve ganhar. Então, em geral, se vocês olharem aqui até 40 semanas, isso aqui é o total que ela vai ganhar durante a gravidez de acordo com o IMC dela. Então é importante saber isso, isso aqui é uma tabela atualizada, a tabela mais atual que a gente tem no Brasil. E é o que a gente espera. Então, não vou entrar em detalhe aqui de quanto que é cada um, isso aqui é para vocês terem ciência, mas é bom memorizar mais ou menos quanto que cada uma dessas mulheres do IMC pré-gestacional poderia ganhar até o final da gravidez, porque eu já vi questão de prova desse jeito. Alimentação saudável, então a gente já adequa o intervalo, a gente orienta não pular refeições, orienta ingestão de alimentos com ferro, ácido fólico, vitamina D, ômega 3, apesar de muitas vezes ser orientado a suplementação, frutas, legumes, carnes, redução de açúcares, frituras e farinhas brancas, diferente do que a gente faz na nossa prática clínica? Não, né gente? É o que a gente já orienta para todos os pacientes grávidas, não grávidas, adultos, enfim, pessoas gerais recebem uma orientação parecida com essa. De exercício físico, ela pode fazer? Não só pode, como deve, desde que seja orientado, assistido, adaptado e sem risco de queda. E que tenha para garantir redução de danos e manutenção do peso. Mas a gente deve respeitar contraindicações. Então, é uma paciente que está com colo curto, é uma paciente que tem ciência cardíaca importante, ela tem alguma contraindicação ao exercício físico, aí ela não pode fazer, obviamente. Mas a maior parte das gestantes pode fazer exercício físico, ainda que seja uma caminhada, porque nem toda gestante vai ter a possibilidade de ter uma piscina para fazer uma hidroginástica. Isso aí é para poucas, né, gente? Então, a gente tem que ensinar o exercício mais fácil para essa mulher. E o que? Ela tem condições. E muitas vezes cabe a nós perguntar para essa mulher, quais são as condições, o que você consegue fazer de exercício. Isso é importante. Exame físico específico. Então a gente vai avaliar mamas e mamilos. A gente vai olhar para os mamilos dessa mulher e ver se eles são preparados para a amamentação. Dependendo, a gente

vai orientar alguma massagem, alguma coisa. A altura uterina. A gente avalia os batimentos cardíacos e fetais. E lembrar que com o sonar Doppler, a partir de 12 semanas a gente já consegue escutar. E com o pinar, que é aquele que a gente coloca o ouvidinho na barriga aqui, que é tipo uma ampulhetinha, um conezinho assim, que a gente coloca e escuta os batimentos do coração do bebê. Isso é com 20 semanas. Em geral, a gente sente a vibração do batimento fetal. Exame especular e toque vaginal. E de suplementação, a gente faz ácido fólico e olha que detalhe interessante. De 1 a 3 meses antes da concepção até o fim da gestação. Então sabe aquela consulta pré-concepcional? É nela que a gente vai orientar essa paciente a usar ácido fólico. Quanto? De 0,4 a 0,8 miligramas dia. Ou 400 a 800 microgramas dia. Mas tem um detalhe. Se ela tiver algum fator de risco, como o distúrbio do tubo neural anterior, o que significa isso? Ela teve um filho, por exemplo, com mielomeningocele. Ou ela é diabética. Ou ela é obesa. Ou ela é pós-bariátrica. Ou ela está usando anticonvulsivante, a gente usa dose maior, a gente usa de 4 a 5 miligramas dia, porque nesses casos a gente tem que prevenir realmente o defeito do tubo neural com uma dosagem um pouco maior. O que mais de suplemento que a gente tem que usar? Sulfato ferroso. O sulfato ferroso é a partir do conhecimento da gravidez até 3 meses pós-parto. Antes, presta atenção, antes, no passado, a gente fazia o sulfato ferroso a partir do segundo trimestre. Então se você tem isso aí na cabeça, mudou. É a partir do conhecimento da gravidez até 3 meses pós-parto. É claro que se ela tiver muitas náuseas, muitos vômitos, eu posso eventualmente suspender o sulfato ferroso do primeiro trimestre. Mas se ela está indo bem, aceitou bem o sulfato ferroso, não teve grande desconforto gastrointestinal, a gente continua desde o primeiro trimestre. Quanto? De 40 a 60 miligramas de ferro por dia. Isso dá 200 a 300 miligramas de sulfato ferroso. Porque a gente tem que dar 40 a 60 miligramas de ferro por dia, ferro elementar. Gente, de suplemento primordial é isso. Existem outros suplementos que são citados na literatura? Existem. Quais? A vitamina D, por exemplo. Isso aqui é Febrasgo, não é Ministério da Saúde. Alguns estudos demonstram diminuição do risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e prematuridade. A Febrasgo recomenda a vitamina D mil unidades dia e manter a vitamina D entre 30 e 60. Ministério da Saúde se posiciona em relação a isso? Não tem posicionamento, gente. Então é difícil dizer, mas isso aqui é recomendação da Febrasgo. DHA, que seria o ômega 3, o composto ativo do ômega 3. Então seria 200mg dia, preferencialmente obtido industrialmente através de algas, se tiver que suplementar, porque ela pode comer peixe o suficiente para ter DHA. Então você pode orientar uma ingesta rica em alimentos originários do mar, mas muitas vezes ela não vai conseguir e por isso às vezes ela tem que suplementar. Isso aqui também fala do mistério? Não fala, mas existe essa recomendação. Fechou? Presta atenção que agora é uma atualização. Gente, aqui está como se risco de pré-eclâmpsia, mas tem um detalhe, olha que interessante. O Ministério da Saúde se posicionou e hoje o cálcio é obrigatório para todas as gestantes brasileiras. Todas. Todas. Porque o que a gente entende? Que o brasileiro é uma população que não come cálcio suficiente, que não ingere cálcio suficiente. E se existe uma redução do risco de pré-eclâmpsia, toda e qualquer gestante vai receber cálcio. A partir de quanto? De pelo menos a vigésima semana. Mas idealmente começar na décima segunda semana. Então preste atenção, o cálcio é para todas. Não é somente se houver risco de pré-eclâmpsia. Mas se houver risco de pré-eclâmpsia, aí o cálcio é mais do que obrigatório. Além dele ser precorizado pelo Ministério da Saúde, se houver o risco, ele é fundamental na prevenção da pré-eclâmpsia. Vocês lembram que as síndromes hipertensivas são a primeira causa de morte materna no nosso país? O intuito de tomar cálcio é também para reduzir isso. Agora, o AS, esse sim, é só para quem tiver risco de pré-eclâmpsia. E aí na aula de pré-eclâmpsia eu explico isso de forma mais adequada para vocês. Então tem isso na aula de pré-eclâmpsia um pouco mais esmiuçado. Mas vocês vejam que existe uma redução de pré-eclâmpsia de forma importante. Orientações gerais numa primeira consulta. Ela vai querer saber de relação sexual? Pode ter ou não pode? Se não tiver contraindicação

nenhuma, pode. Repouso, tem que fazer? Em geral não. Ela pode seguir a vida dela de uma forma normal, desde que não se coloque em risco. Constipação intestinal, pode ter? Pode. E aí a gente vai ter que orientar dieta, ingestão de líquido, de fibras. Atividades físicas, pode fazer? Deve. Aquáticas preferencialmente, mas é todo mundo que vai poder? Não. Fumo? Deve fumar? Lógico que não, deve orientar a parar o tabagismo. Álcool? Mesma coisa, deve orientar a parar o etilismo. Drogas ilícitas? Nem se fala, né gente? Medicamentos. Ajustar ali os medicamentos que ela eventualmente já toma. Adoçantes. Pode tomar adoçante? Pode. Todos os adoçantes são liberados na gravidez. Existem alguns mais estudados? Existem. Então, aspartame, sucralose, são mais estudados, mas eles podem ser utilizados durante a gravidez. Tá certo? Exame de radiografia pode fazer? A princípio, gente, evitar o primeiro trimestre, mas pesar risco-benefício. A gente tem que lembrar que a mulher também, eventualmente, ela vai precisar de algum exame a mais, porque ela pode ter intercorrências clínicas durante a gravidez. Eu tive um caso recente nesse momento que eu estou gravando aqui de uma gestante que teve uma suspeita de um c renal que n foi visto no ultrassom e eu precisei pedir uma tomografia para ela. Ela estava grávida de gêmeos e fez a tomografia, e viu lá o cálculo. Então, assim, precisava ter feito para a gente resolver a dor da paciente. Então, nessa situação, a gente eventualmente vai considerar. Profissão, avaliar se oferece algum risco. Vestuário e meias ortopédicas, então orientar que meia elástica é sempre bom. E as viagens de transporte também é uma pergunta que sempre se faz. Então avaliar a questão de companhia aérea quando for viajar de avião, tudo isso. E orientar que o uso de meia elástica é fundamental para aquelas pacientes que vão se expor a viagens mais longas. E nas consultas subsequentes? Então a gente pergunta sobre os sintomas anteriores e novos sintomas. E aí o que a gente tem de sintoma possível? Fraqueza e desmaio no segundo trimestre, porque é um período que tem hipotensão, dor abdominal, cólica, flatulência, obstipação intestinal, sangramento gengival, dispneia, epistaxe, aumento do número de micções, câimbras, corrimento vaginal, pica ou malássia, que são aqueles desejos esquisitos e esdrúxulos de comer coisas esquisitas, sonolência e o crescimento uterino, que vai gerando um pouco de desconforto. Segundo trimestre isso. E no terceiro, tem alguma queixa? Tem. Mais comum, né gente? Porque todas elas podem aparecer basicamente em todos os trimestres. Modificação da postura que vai gerar dor lombar, varizes, hemorroidas, cloasma gravítico, que é aquela mancha escura em face, estrias, desconforto para dormir, espineia, edema, ganho de peso, cansaço. E nas consultas subsequentes a gente também vai continuar fazendo o exame físico. A gente vai avaliar o aumento de peso, a gente vai ver os níveis pressóricos. E aí, nos níveis pressóricos, a gente tem que lembrar das doenças hipertensivas. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou diastólica maior ou igual a 90 é hipertensão. Aí pode ser hipertensão crônica, se for antes de 20 semanas ou prévia à gestação. Pode ser hipertensão gestacional, se for após 20 semanas sem preencher critérios para pré-eclâmpsia. Pode ser pré-eclâmpis, se for após 20 semanas, mais pelo menos um dos seguintes, das coisas que estão escritas ali embaixo. Mas isso também vocês vão ver muito bem na aula de síndromes hipertensivas na gravidez. É só para mostrar que isso faz parte da nossa consulta pré-natal e do diagnóstico durante a consulta. A altura uterina. Aqui, nas consultas subsequentes, a altura uterina, como é que a gente faz? A gente pega o bordo superior da sínfise púbica, vai até o útero, coloca a mãozinha perpendicular ao fundo uterino e mede quanto que deu isso. A altura uterina a gente vai jogar numa tabela e a gente vai ver se está dentro do percentil 10 e 90 e vai ver a curva de crescimento dessa barriga, para ter uma noção se o neném está seguindo a mesma curva. Agora tem um detalhe interessante. Existe um jeito de a gente calcular mais ou menos a idade gestacional baseada na altura uterina? Existe. Então, imaginem vocês. Uma paciente sofreu um acidente, ela está desacordada e ela tem uma barriga de grávida. Você mede essa barriga e se tem só a altura uterina. Você pode fazer a regra de McDonald's aqui. A idade gestacional vai ser a altura uterina vezes oito sétimos. E aí você consegue ter uma estimativa de

qual é a idade gestacional dessa paciente. Vamos ver um exemplo aqui de alteração de altura uterina? Então eu tenho aqui o gráfico e nesse gráfico eu tenho uma altura uterina que está aqui. Então está abaixo do percentil 10. É uma gestante que tem 33 semanas de gestação que está com uma altura uterina de 25. O que pode ser isso, gente? Então se está abaixo do percentil 10, o que eu vou pensar? Qual é a hipótese diagnóstica? Posso pensar que tem pouco líquido? Posso. Aí a barriga fica menor. Posso pensar que tem um erro de data? Também posso. Errei a data, calculei errado. De repente não é aquela idade gestacional que eu coloquei no gráfico. Então tem que recalcular. Pode ser uma restrição de crescimento hidrúterino? Pode, o neném cresceu pouco e por isso está ficando menor a barriga. E qual seria a conduta? Uma ultrassonografia obstétrica. Então se eu vi que uma barriga está menor do que esperado para a idade gestacional, eu faço uma ultrassonografia. Só que tem um detalhe. Se eu encontro uma ultrassonografia normal, se o feto está normal, Dentro do percentil esperado, entre 10 e 90. E se o líquido está normal, eu considero essa ultrassonografia normal. E eu não considero uma restrição de crescimento. Então a altura uterina é um exame meio que de rastreio. Eu vou observar e imaginar hipóteses. Mas a ultrassonografia é que vale confirmar se existe uma restrição ou não. E se na curva tivesse maior do que o percentil 90? O que eu poderia pensar? Posso pensar em polidrâmine, então tem mais líquido do que o esperado. Posso pensar num feto grande para a idade gestacional, que é um feto não necessariamente macrossômico, significa que ele está crescendo mais rápido do que eu esperado, acima do percentil 90. Mas pode ser também um erro de data. E lembrando, se o transom vier normal, eu considero normal. O que mais? Manobra de Leopold Zweifel. Então isso faz parte do exame físico também, vocês lembram dela? São quatro manobras. Então eu vejo aqui qual que é o polo do feto que está aqui em cima, no fundo uterino. Eu jogo as mãos para a lateral e vejo onde está o dorso, onde estão os membros. Aí eu vejo qual que é o polo que está aqui embaixo, vejo se ele está móvel ou insinuado. Então através dessas duas manobras eu vou ver qual que é o polo que está apresentando. Então é o polo pélvico ou é o polo cefálico ou é o cômico. E eu vejo também se existe mobilidade, se é um feto que já está encaixado ou não. Lembrando que essa quarta manobra, o examinador vira de costas para a paciente para fazer o exame. Então essa quarta manobra é diferente. Enquanto a gente está fazendo a palpação da paciente, sempre à direita da paciente, aqui a gente faz essa palpação com as costas para a paciente. Fechou? Então, consultas subsequentes. O que mais que a gente faz, além da manobra de Leopold Zweifel? Avalie movimentação fetal. Então, geralmente vai começar entre 19 e 20 semanas. Mas a gente vai sentir entre 19 e 20 semanas? Não. Quem sente é a mulher. A gente vai sentir um pouquinho mais adiante. Os batimentos cardíacos fetais. Consigo escutar? Consigo. Lembrar daquela história do sonar dupla até 12 semanas e do pinar a partir de 20 semanas. Sonar dupla a partir de 12 e hipnar a partir de 20 semanas. Avalio também edema. Essa mulher já está inchando ou não? O que mais que eu faço durante o pré-natal? Eu faço imunização, eu vou preconizar vacinas para essa mulher. Quais vacinas que são preconizadas? Influenza, hepatite B, difteria tétano e coqueluche, a celular, coronavírus e agora, mais recentemente, o vírus sincicial respiratório. Como é que funciona? Vacina de influenza. Ela é aplicada em qualquer trimestre, então pode aplicar no primeiro trimestre? Pode. É uma dose única anual e se a gestante foi imunodeprimida, eu posso considerar uma segunda dose a partir de 3 meses após a dose anual. E um detalhe é que ela é gratuita no SUS. Hepatite B, eu vejo se ela tem história vacinal. Já foi vacinada em 3 doses? Se já foi, em geral eu não vacino de novo, a não ser que ela seja um extremo grupo de risco. Porque eu não vou esperar, se ela não está exposta ao vírus, que ela tem título de anticorpos elevados. Deu dúvida se ela foi vacinada? Você pode fazer o que a gente chama de dose booster, dose desafio. Você faz uma dose da vacina, em 30 dias você coleta o anti-HBs. Se o anti-HBs estiver estourado, estiver super positivo, significa que ela já foi imunizada. Faço essa vacina também em qualquer trimestre. A vacina são três doses, então eu faço zero, um

mês após e seis meses após a primeira dose. E ela também é gratuita no Sistema Único de Saúde. DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche. A gente tem cenários possíveis. Então essa paciente já tomou três doses de vacina do tétano. Então, ela vai tomar somente uma dose a partir da vigésima semana de gestação, de DTPA. Ela tem a vacina incompleta, falta só uma dose, ela vai completar essa dose já com uma DTPA. Então, perdão, aqui ela tomou só uma dose na vida. Então, se ela tomou só uma dose na vida, ela precisa fazer mais duas doses. Sendo que ela vai fazer uma dose de DT e uma dose de DTPA a partir da vigésima semana. E tem que ter no mínimo um mês entre elas. Se ela tem duas doses tomadas, né? Então se ela já tomou duas doses, eu vou fazer só uma dose de DTPA, porque com isso eu completo o esquema e garanto o componente perturce. O objetivo dessa vacina é prevenir coqueluche e tétano neonatal e nos recém-nascidos, tá? Então a ideia aqui de vacinar essa gestante é pra isso. E se ela não for vacinada ou não tiver histórico vacinal, A gente faz duas doses de DT e uma dose de DTPA a partir da vigésima semana. A DTPA tem que ser sempre a partir da vigésima semana. O tétano não pode ser aplicado inclusive no primeiro trimestre. Lembrando que o intervalo mínimo é de um mês entre elas. Mulheres não vacinadas na gestação podem ser vacinadas no puerpério até 45 dias pós-parto. O mais precocemente possível. Um detalhe importante aqui, gente, é que essa mulher deve ser vacinada em toda e qualquer gestação. Então se ela foi vacinada agora e engravidou de novo daqui a um mês, então ganhou o neném ali. Um mês depois ela engravidou. Raro, mas pode acontecer. Um mês depois ela engravidou, ela vai tomar outra dose de DTPA, independentemente do histórico vacinal dela. E essa vacina também é gratuita no SUS. Coronavírus. Tem que tomar ainda corona? Tem. Por dois motivos. Primeiro porque protege a mãe e segundo porque protege o bebê. Hoje uma das grandes causas de internação de recém-nascidos e de bebês até seis meses de idade é o coronavírus. E está matando os bebezinhos. Então vacinar a gestante também faz com que haja uma passagem de anticorpos pela placenta e esse bebê nasça mais protegido contra o coronavírus. Então o objetivo agora também é a proteção do bebê. É uma vacina que é feita anualmente e a cada gestação e ela também é gratuita. E essa vacina está disponível somente na rede pública. Se você quiser na rede privada, você não vai encontrar. Não existe essa vacina na rede privada. Então tem que orientar ela a tomar na rede pública sempre. Vírus essencial respiratório. Vacina recém-aprovada pela Conitec. Então é uma vacina nova que previne bronquiolite nos bebezinhos. A vacina que é disponível para isso é a Brisvo, é a única vacina disponível para aplicação na gestante. Então essa é a vacina que deve ser feita. Ela é uma dose intramuscular a partir de 28 semanas de gravidez. Indicada em qualquer momento, independentemente da sazonalidade. E ela foi licenciada pela Anvisa a partir de 24 semanas. Então, eventualmente, você pode antecipar a vacinação para antes de 28 semanas, se for necessário. Mas, a princípio, a recomendação é que ela seja aplicada a partir de 28 semanas de gravidez. Vacinas em situações especiais. Febre amarela, raiva, hepatite A, pneumocócica, meningocócica e meningocócica B. Febre amarela, por que tem dois asteriscos? Porque a febre amarela, gente, ela é uma vacina que a princípio é contraindicada. Mas se eu estou num cenário em que eu tenho um surto de febre amarela, eu posso indicar a vacina contra a febre amarela. Então está rolando muita morte de pessoas com febre amarela. Eu vou deixar minha gestante susceptível a febre amarela? Não. Se ela não tiver histórico vacinal, eu tenho que vaciná-la. Lembrando que hoje a febre amarela s uma dose durante a vida toda se ela tiver tomada a dose plena Raiva Se ela tiver alguma exposi Hepatite A se ela tiver risco a se ela n tiver imunidade por exemplo No SUS não existe essa recomendação ainda, mas pode ser considerada para aquela que queira eventualmente pagar pela vacina. Alguns grupos especiais, por exemplo, imunossuprimidos, têm indicação da vacina durante a gravidez. A mesma coisa para a pneumocócica, meningocócica, etc. E em relação às imunoglobulinas em situações especiais, se ela tiver um contato com alguém que tenha catapora e ela nunca teve catapora na vida ou não foi

vacinada, ela tem que fazer imunoglobulina até 72 horas após o contato. Se a exposição foi com sarampo e ela também não é vacinada, até 6 dias do contato. Se ela teve uma exposição a hepatite B, a gente faz a imunoglobulina mais a vacina. Raiva, se ela tiver tido uma exposição que precise de imunoglobulina. Tétano, mesma coisa. Imagina uma perfuração por prego, enferrujado, aquela história toda. E lembrar que se ela for RH negativo, tiver cúmbis indireto negativo, e o pai for RH positivo, e por isso o feto tem possibilidade de ser RH positivo, tem que fazer a imunoglobulina anti-RH. Então algumas imunizações relacionadas à imunoglobulina. E de vacina contraindicada. HPV, triplice viral, varicela, dengue, febre amarela. Por que a febre amarela entrou aqui de novo? Justamente por isso, porque ela é contraindicada se eu não estiver num cenário de risco. Se eu estiver num cenário em que essa gestante não tem risco de febre amarela, a princípio eu não vacino essa mulher. A poliomielite oral também é proibida, é proscrita, melhor dizendo. E a BCG também. Vejam que isso aqui são coisas que tem vírus atenuado, muitos deles. Então vírus ou bactérias, enfim. Então a gente não tem recomendação de fazer na gravidez. De exames complementares, o que a gente vai fazer? Então no primeiro trimestre, vou fazer hemograma e ferritina sérica. A ferritina, gente, isso aqui é controverso, tá? O Ministério da Saúde não coloca a ferritina como exame primordial. Então presta atenção no que eu estou falando. O Ministério da Saúde não coloca a ferritina. Mas cada vez mais existe a recomendação da gente dosar a ferritina. Porque se ela tiver uma deficiência de ferro, isso vai ser importante para a gente repor o ferro de uma forma diferente. Faz tipagem a BORH e faz cúmbis indiretos, principalmente se ela for RH negativo. Faz uma glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é obrigatória para todas? Também não. Faz a glicemia de jejum que é o principal. Urina 1, ourocultura e antibiograma. E o TSH. O que o Ministério da Saúde fala? Que o TSH, se a gente tiver disponibilidade, for um exame fácil, acessível, a gente pode recomendar e pode fazer. Mas é obrigatório? Não. E a ferritina eu coloquei de novo porque ela é interrogada. É aquilo que eu falei ali em cima, tá? Então não necessariamente vai fazer a ferritina. De exames sorológicos, teste rápido para sífilis, teste rápido para HIV e anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG, hepatite B, que a gente faz o HBS e a G, se o HBS e a G tiver negativo, a princípio eu não preciso continuar a investigação, mas a gente tem que ver também se essa paciente tem história vacinal contra a hepatite B, porque se não tiver, ela precisa ser vacinada na gravidez, Hepatite C entrou no calendário das sorologias a serem pedidas para a gestante, porque se a gente faz o diagnóstico, ela pode ser encaminhada para o tratamento após o término da gravidez. Rubela, a gente pede principalmente para ver se ela tem imunidade, se ela tem IgG. Se ela não tiver IgG, a gente orienta a vacinação após o término da gravidez. Sorologia para citomegalovírus é super controversa, Mas a gente, se tiver disponível, pode solicitar. HTLV virou obrigatório pelo Ministério da Saúde também. Então HTLV a gente coleta para toda e qualquer gestante, porque a gente tem que suspender a amamentação se ela tiver o HTLV positivo. E a gente pode testar o IgG para parvovírus B19 para pessoas específicas, professores de escolas ou funcionários de creches, devido à associação dele com hidropsia fetal não imune. O que é hidropsia fetal não imune? Esse feto faz uma anemia grave e ele faz uma anasarca, ele faz um edema e esse edema é conhecido como hidropsia fetal. É um quadro grave que pode inclusive levar a óbito. Quando a gente tem uma gestante com mais de 30 anos, eu também devo fazer uma pesquisa de clamídia e gonococo para essa mulher. Então, tem mais de 30 anos, pesquisa de clamídia e gonococo para essa mulher. Não obrigatórios, compostologia oncótica, então isso é se necessário, se tiver na janela de oportunidade. Lembrar que o Ministério da Saúde incorporou recentemente a pesquisa molecular para o HPV, então, a depender do local onde estiver esse HPV já vai ser a forma como deve ser investigada essa questão do colo uterino. Exame de secreção vaginal, se necessário. Parasitológico de fezes também não é recomendado para todo mundo, se ela tiver uma história, se ela tiver um fator de risco, se ela tiver uma anemia que não melhora. Eletroforese de hemoglobina,

se tiver uma história de anemia que não melhora, se tiver história familiar, por exemplo, de anemia falciforme ou de traço falcêmico. A gente pede uma proteinúria para que elas são hipertensas de base, justamente para poder comparar lá na frente. Com pré-eclâmpsia, para aquelas pacientes que fizerem pré-eclâmpsia. E eu posso pedir gota espessa naquelas que forem regiões endêmicas para malária. O que mais que a gente pede no segundo trimestre? TOTG 75 gramas, se a glicemia for abaixo de 92. Então, se eu fiz a glicose lá do comecinho e deu abaixo de 92, ela não tem diabetes lá naquele começo. Então eu peço entre 24 e 28 semanas. Peço um cumbis indireto, se o RH for negativo. E peço um eco fetal. Então se ela tiver uma história familiar de cardiopatia, se tiver uma idade materna maior do que 35 anos, enfim, tem alguns critérios. Isso aqui é uma complexidade grande, porque há pouco tempo surgiu uma lei que falava que toda paciente devia fazer eco cardiograma, mas fetal no caso, e aí virou um bafafá porque as sociedades se manifestaram, a febrásica se manifestou. E assim, gente, o que a princípio tem de recomendação é que a gente faça nesses grupos aqui, tá? No terceiro trimestre, o que a gente vai fazer? Um hemograma, cumbis indireto, CRH negativo, sífilis, HIV, um teste rápido. Então a gente repete meio que as serologias. Hepatite B, a gente pode pedir o HBS-AG, tá? De novo. Toxoplasmose, se ela for susceptível. Urina 1, urocultura. Lembrando que a toxo, gente, o ideal é que a gente faça de forma mensal, tá? Então todos os meses a gente vai avaliando a toxo. Algumas coisas aqui, a gente tem questões específicas que a gente discute ao longo das aulas específicas para cada um desses temas, tá? E lembrar que 36 a 37 semanas e 6 dias a gente deve fazer o teste também, que é o estreptococcus do grupo B. E quais são as indicações da ultrassonografia? Então é importante, gente, a ultrassonografia. Então a gente serve para datar a gestação, serve para localizar o número de sacos gestacionais, serve para avaliar a vitalidade embrionária, está vivo ou não está esse neném. A gente avalia sinais de mal prognóstico, avalia os anexos e faz uma avaliação de sangramento de primeiro trimestre. Então a ultrassonografia tem uma grande importância hoje. É difícil a gente viver hoje, fazer um pré-natal, fazer um atendimento obstétrico de qualidade sem a ultrassonografia. Ela é fundamental. Entendo que mesmo a febrasgo se posicionando, a gente sabe que tem que ter pelo menos 3 ultrassonografias ao longo da gravidez. Então seria um morfológico de primeiro trimestre, um morfológico de segundo e aí um exame pelo menos no terceiro trimestre. Mínimo, pelo que é preconizado no Brasil. O Ministério fala que não é um exame obrigatório e a gente compreende isso, porque você está falando de um protocolo que vai ser utilizado no país todo. Mas ele fala também que se você tem disponível isso como método complementar, que você faça. Bom, sim, a gente deve fazer. Então, no primeiro trimestre, de 6 a 9 semanas, a gente faz via vaginal. Depois de 11 a 14 semanas, quando a gente tem um comprimento cabeça nádega de 45 a 84 milímetros, a gente faz via abdominal com Doppler, para avaliação do morfológico, né? Esse aqui seria o morfológico. No segundo trimestre, de 18 a 24 semanas, a gente faz o morfológico também, para avaliar a malformação e cromossomopatias. E no terceiro trimestre, a gente deveria fazer um entre 34 e 36 semanas, para avaliar crescimento fetal, dopre, perfil biofísico fetal, dentre outras coisas. Então isso aqui seria um ideal, um cenário ideal, pelo menos 4 tracionografias. 3 é o mínimo, mas a gente pode considerar um quadro como esse aqui como o ideal para a gente fazer. E aí tem o plano de parto, gente. O plano de parto é uma coisa interessante para discutir durante o pré-natal. Ele é o primeiro de uma série de recomendações da OMS que fala um passo a passo do parto. Essa mulher vai ser orientada de como ela gostaria que o parto dela fosse. Então o objetivo é evitar imprevistos de difícil solução. Então você imagina, essa mulher vai chegar no hospital, o médico que vai atender ela não a conhece, mas ela quer demonstrar quais são os desejos dela em relação ao parto. Então isso garante que ela seja protagonista desse momento. E aí a gente tem as preferências claras do que ela quer para a equipe. E ele é um documento norteador das escolhas da mulher. Ele não é um documento obrigatório. Não é porque ela quer que seja feito aquilo que obrigatoriamente será feito



aquilo. Ele é norteador. Eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que seja assado. Mas virou uma situação de emergência, a gente tem que discutir com a mulher. Olha, eu sei que você gostaria que fosse assim, mas se a gente não fizer alguma coisa neste momento, seu bebê pode morrer ou você pode morrer. Enfim, então existem mudanças que podem ser feitas ao longo do processo. Fechou? E pra finalizar, eu trago mais uma atualização que é mega importante, que vale a pena discutir em toda e qualquer consulta pré-natal. Vem conferir. O que eu quero falar, gente, é o conceito de epigenética. Vocês já ouviram falar nisso? Epigenética é um conceito simples. Eu tenho o DNA, eu tenho o cromossomo e eu tenho meus genes ali naquele DNA. Então eu, Fabiano, nasci com aqueles genes ali. Mas desde o momento intraútero, de acordo com a exposição que eu tenho intraútero, então se eu sou o filho de uma mulher que é obesa, hipertensa, diabética, que come super mal, que não faz exercício físico, isso me predispõe a determinadas doenças no futuro. Por quê? Qual que é o conceito de epigenética? Eu tenho o gene, mas eu posso ligar ou desligar esse gene de acordo com o ambiente que está sendo formado ali. Então, é como se eu expressasse ou não esse gene. Então, isso o ambiente determina essa expressão ou não gênica. Então é muito importante que a gente oriente que o que essa mulher faz durante a gravidez pode repercutir durante toda a vida desse bebê, dessa criança, desse adulto e até a idade mais velha lá, a velhice mesmo. Então, o que ela faz com esse bebê intraútero pode repercutir ao longo de toda a vida. E isso fica o conceito para vocês também. É importante que a gente olhe com carinho, para a gente também. Porque a gente também pode determinar a manifestação ou não de determinados genes ao longo da nossa vida. Mas principalmente nessa fase intrauterina. Fechou? Quais são os principais pontos a serem abordados durante uma gestação de baixo risco? Eu conversei com vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula meio extensa, às vezes até um pouco chata, eu sei disso, mas ela é super importante porque ela chove nas provas. Tem que saber assistência pré-natal. Existe mais uma aula na qual eu vou falar sobre as intercorrências relacionadas ao pré-natal. Seria um aprofundamento dessa aula, porque não dá pra falar tudo de assistência pré-natal, o que a gente faz em nove meses em apenas uma aula. Combinado, gente? Vejo vocês numa próxima. Até lá!